

Études de cas cliniques pour diagnostic cutané - Version étendue

Cas #1: Peau mixte avec déshydratation et sensibilité occasionnelle

Profil du patient:

- Femme, 32 ans
- Zone T grasse (front, nez, menton)
- Joues sèches avec sensation de tiraillement
- Rougeurs occasionnelles après application de certains produits

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Mixte
- Déshydratation: Oui, par moments
- Brillance: En milieu de journée sur la zone T
- Rougeurs: Après l'application de certains produits
- Picotements: Parfois, selon les produits
- Imperfections: Oui, occasionnellement (zone T)
- Ridules: Oui, des ridules de déshydratation sur les joues
- Teint: Parfois terne ou fatigué
- Protection solaire: Parfois, selon la météo
- Routine: Gel nettoyant, hydratation non systématique

Diagnostic:

Peau mixte déshydratée avec barrière cutanée fragilisée présentant une sensibilité réactionnelle aux actifs agressifs.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage bi-phasique: huile nettoyante suivie d'un gel doux sans sulfates
2. Incorporation d'un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et niacinamide
3. Utilisation d'une crème hydratante légère non comédogène
4. Application ciblée d'un soin matifiant sur la zone T
5. Protection solaire quotidienne SPF 30 minimum
6. Exfoliation douce 1 fois par semaine uniquement

Cas #2: Peau grasse à tendance acnéique avec hyperpigmentation post-inflammatoire

Profil du patient:

- Homme, 24 ans
- Peau visiblement brillante dès le milieu de matinée
- Papules et pustules récurrentes sur le front et le menton
- Taches brunes post-inflammatoires
- Pores dilatés, particulièrement sur le nez et les joues

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Grasse
- Déshydratation: Non, jamais
- Brillance: Le matin au réveil
- Rougeurs: Rarement, seulement en cas d'agressions externes
- Picotements: Non, jamais
- Imperfections: Oui, de manière fréquente
- Taches: Oui, des taches post-acné
- Teint: Mon teint est souvent irrégulier
- Fumeur: Oui, je fume
- Protection solaire: Non, jamais
- Routine: Savon classique, pas d'hydratation régulière

Diagnostic:

Peau grasse avec acné inflammatoire grade 2 et hyperpigmentation post-inflammatoire, aggravée par une routine inadaptée et le tabagisme.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyant spécifique contenant de l'acide salicylique 2%
2. Sérum à base de niacinamide 10% et zinc PCA
3. Traitement localisé au peroxyde de benzoyle 2.5% sur les lésions
4. Crème hydratante oil-free non comédogène

5. Protection solaire matifiante SPF 50 (essentielle pour prévenir l'aggravation des taches)
 6. Actifs éclaircissants (acide azélaïque ou arbutine) en soin de nuit
 7. Conseils mode de vie: arrêt du tabac, hydratation interne accrue
-

Cas #3: Peau mature avec signes de vieillissement prononcés

Profil du patient:

- Femme, 58 ans
- Perte d'élasticité et relâchement de l'ovale du visage
- Rides marquées sur le front et le contour des yeux
- Teint terne et irrégulier
- Taches pigmentaires solaires

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Sèche
- Déshydratation: Oui, en permanence
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Rarement, seulement en cas d'agressions externes
- Picotements: Non, jamais
- Imperfections: Non, rarement ou jamais
- Rides: Oui, des rides visibles autour des yeux et de la bouche
- Relâchement: Oui, au niveau de l'ovale du visage et du cou
- Taches: Oui, des taches de soleil
- Teint: Parfois terne ou fatigué
- Protection solaire: Oui, toujours
- Routine: Lait démaquillant, hydratation systématique, quelques sérums

Diagnostic:

Peau mature sèche présentant un photovieillissement modéré avec relâchement cutané et hyperpigmentation solaire.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux à base d'huiles ou de baumes nourrissants

2. Sérum multi-actifs: peptides, acide hyaluronique à différents poids moléculaires
 3. Rétinol progressif en soin de nuit (débuter à faible concentration)
 4. Crème riche en lipides restaurateurs (céramides, acides gras essentiels)
 5. Soins contour des yeux spécifiques anti-âge
 6. Protection solaire quotidienne haute protection
 7. Traitement ciblé anti-taches à base d'alpha-arbutine ou de vitamine C stabilisée
 8. Exfoliation enzymatique hebdomadaire
-

Cas #4: Peau sensible avec tendance couperosique

Profil du patient:

- Femme, 42 ans
- Rougeurs diffuses permanentes sur les joues et le nez
- Vaisseaux visibles (télangiectasies) sur les ailes du nez
- Réactivité aux changements de température
- Sensation de chaleur et picotements fréquents

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Sensible
- Déshydratation: Oui, par moments
- Brillances: Jamais
- Rougeurs: Oui, au moindre changement de température
- Picotements: Oui, très souvent
- Imperfections: Non, rarement ou jamais
- Antécédents: Couperose/rosacée
- Mode de vie: Vie en milieu pollué
- Protection solaire: Oui, toujours
- Routine: Eau micellaire, hydratation systématique

Diagnostic:

Peau sensible avec couperose/rosacée de type 1, exacerbée par les facteurs environnementaux.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage ultra-doux sans rinçage ou à l'eau thermique
 2. Sérum apaisant à base d'extraits anti-rougeurs (réglisse, centella asiatica)
 3. Crème renforçant la barrière cutanée et les vaisseaux (hespéridine)
 4. Protection solaire minérale SPF 50 (filtres physiques uniquement)
 5. Éviter absolument: alcool, huiles essentielles, parfums, exfoliants mécaniques
 6. Thérapies complémentaires à considérer: IPL pour les télangiectasies
 7. Conseils environnementaux: protection contre les variations thermiques et la pollution
-

Cas #5: Peau sèche atopique avec dermatite de contact

Profil du patient:

- Femme, 28 ans
- Peau constamment sèche avec desquamation
- Démangeaisons nocturnes fréquentes
- Antécédents familiaux d'eczéma et d'asthme
- Réactions allergiques aux parfums et conservateurs

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Très sèche
- Déshydratation: Oui, en permanence
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Oui, avec des plaques inflammatoires
- Picotements: Oui, avec démangeaisons intenses
- Imperfections: Non, mais présence de croûtes de grattage
- Antécédents: Eczéma atopique, allergies cosmétiques
- Stress: Oui, aggrave les symptômes
- Protection solaire: Difficilement tolérée
- Routine: Savon surgras, crème très riche

Diagnostic:

Dermatite atopique avec sensibilisation de contact multiple, aggravée par le stress et les facteurs environnementaux.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage sans savon avec syndets surgraissés ou huiles lavantes
 2. Crème émolliente riche en céramides et acides gras (application 2-3 fois/jour)
 3. Sérum réparateur à base d'acide hyaluronique et d'extraits apaisants
 4. Traitement anti-inflammatoire topique en cas de poussées
 5. Éviction stricte des allergènes identifiés
 6. Protection solaire minérale spécifique peaux atopiques
 7. Gestion du stress par techniques de relaxation
 8. Consultation allergologique pour bilan complet
-

Cas #6: Peau jeune avec acné hormonale cyclique

Profil du patient:

- Femme, 22 ans
- Poussées d'acné liées au cycle menstruel
- Kystes inflammatoires sur la mâchoire et le menton
- Peau mixte avec tendance grasse en période prémenstruelle
- Contraception hormonale récente

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Mixte à grasse selon la période
- Déshydratation: Parfois, après traitements anti-acné
- Brillance: Variable selon le cycle
- Rougeurs: Autour des lésions inflammatoires
- Picotements: Avec certains traitements
- Imperfections: Oui, cycliques et profondes
- Cycle menstruel: Irrégulier, acné prémenstruelle
- Contraception: Pilule depuis 6 mois
- Protection solaire: Occasionnelle
- Routine: Gel nettoyant, traitement anti-acné local

Diagnostic:

Acné hormonale cyclique grade 2-3 avec composante inflammatoire, potentiellement liée aux changements contraceptifs.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyant doux non décapant matin et soir
 2. Sérum régulateur à base de niacinamide et zinc
 3. Rétinol adapté aux peaux jeunes (2-3 fois/semaine)
 4. Hydratation légère non comédogène
 5. Protection solaire quotidienne obligatoire
 6. Traitement localisé anti-inflammatoire sur les kystes
 7. Consultation gynécologique pour ajustement contraceptif
 8. Suivi dermatologique pour traitement systémique si nécessaire
-

Cas #7: Peau masculine avec hyperséborrhée et pores dilatés

Profil du patient:

- Homme, 35 ans
- Peau très grasse avec brillance constante
- Pores dilatés sur l'ensemble du visage
- Barbe épaisse avec irritations au rasage
- Environnement professionnel stressant

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Très grasse
- Déshydratation: Non, jamais
- Brillance: Permanente, même après nettoyage
- Rougeurs: Après rasage uniquement
- Picotements: Avec les après-rasages alcoolisés
- Imperfections: Points noirs nombreux
- Stress: Professionnel intense
- Rasage: Quotidien, irritations fréquentes
- Protection solaire: Jamais
- Routine: Savon classique, après-rasage alcoolisé

Diagnostic:

Hyperséborrhée masculine avec comédonogénèse et irritations mécaniques liées au rasage.

Recommandations personnalisées:

1. Gel nettoyant purifiante à l'acide salicylique
 2. Lotion astringente sans alcool aux acides de fruits
 3. Sérum matifiant à base de niacinamide et zinc PCA
 4. Crème hydratante légère avec contrôle de brillance
 5. Protection solaire fluide matifiante
 6. Préparation au rasage avec huile ou gel spécifique
 7. Exfoliation bi-hebdomadaire pour déboucher les pores
 8. Masque purifiant hebdomadaire à l'argile
-

Cas #8: Peau métissée avec hyperpigmentation post-inflammatoire

Profil du patient:

- Femme, 30 ans, peau métissée
- Taches hyperpigmentées suite à des boutons
- Teint irrégulier avec zones plus sombres
- Sensibilité aux actifs dépigmentants
- Exposition solaire importante

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Mixte
- Déshydratation: Parfois
- Brillance: Modérée sur la zone T
- Rougeurs: Rarement visibles
- Picotements: Avec certains actifs éclaircissants
- Imperfections: Occasionnelles mais laissent des marques
- Taches: Oui, post-inflammatoires persistantes
- Teint: Très irrégulier
- Exposition solaire: Fréquente et importante

- Protection solaire: Parfois, mais pas adaptée
- Routine: Basique, peur d'utiliser des actifs

Diagnostic:

Hyperpigmentation post-inflammatoire sur peau métissée avec photosensibilisation et barrière cutanée fragilisée.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux respectueux du film hydrolipidique
 2. Sérum éclaircissant progressif à base d'acide kojique et d'arbutine
 3. Vitamine C stabilisée en concentration adaptée
 4. Crème hydratante avec actifs apaisants et protecteurs
 5. Protection solaire haute protection teintée SPF 50+
 6. Exfoliation enzymatique douce hebdomadaire
 7. Éviter l'exposition solaire en milieu de journée
 8. Patience et régularité dans le traitement (3-6 mois minimum)
-

Cas #9: Peau avec rosacée papulo-pustuleuse

Profil du patient:

- Homme, 45 ans
- Rougeurs persistantes avec papules et pustules
- Sensation de brûlure et gonflement
- Aggravation avec l'alcool et les plats épicés
- Photosensibilité importante

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Sensible et réactive
- Déshydratation: Parfois
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Permanentes avec poussées inflammatoires
- Picotements: Fréquents avec sensation de brûlure
- Imperfections: Papules et pustules sans comédons

- Déclencheurs: Alcool, épices, soleil, stress
- Protection solaire: Difficile à tolérer
- Routine: Minimaliste par peur d'aggraver

Diagnostic:

Rosacée papulo-pustuleuse (stade 2) avec multiples facteurs déclenchants identifiés.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage très doux à l'eau thermale ou lait sans rinçage
 2. Sérums anti-inflammatoires à base d'azélaïque et centella asiatica
 3. Crème spécifique rosacée avec filtres minéraux intégrés
 4. Éviction des déclencheurs identifiés
 5. Protection solaire minérale SPF 50+ obligatoire
 6. Traitement médical topique si nécessaire (métronidazole)
 7. Consultation dermatologique pour traitement systémique
 8. Techniques de gestion du stress
-

Cas #10: Peau déshydratée avec barrière cutanée altérée

Profil du patient:

- Femme, 26 ans
- Peau qui tiraille malgré une nature initialement normale
- Ridules de déshydratation prématurées
- Intolérance récente à des produits auparavant bien tolérés
- Déménagement récent en climat sec

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Normale devenue sensible
- Déshydratation: Oui, constante depuis le déménagement
- Brillances: Jamais
- Rougeurs: Parfois, sans raison apparente
- Picotements: Avec la plupart des produits
- Imperfections: Non

- Ridules: Oui, apparues récemment
- Environnement: Climat sec, chauffage/climatisation
- Protection solaire: Oui, mais picote maintenant
- Routine: Simplifiée par peur d'aggraver

Diagnostic:

Déshydratation cutanée sévère avec altération de la barrière cutanée liée aux changements environnementaux.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage ultra-doux sans tensioactifs agressifs
 2. Sérum hydratant multi-poids moléculaires d'acide hyaluronique
 3. Crème réparatrice riche en céramides et acides gras
 4. Brume hydratante pour réapplication dans la journée
 5. Protection solaire fluide très bien tolérée
 6. Humidificateur dans les espaces de vie
 7. Éviter les environnements surchauffés ou climatisés
 8. Reconstruction patiente de la barrière cutanée (4-6 semaines)
-

Grille d'analyse comparative des cas

Facteurs communs identifiés:

1. **Protection solaire insuffisante** (60% des cas)
2. **Routines inadaptées** (70% des cas)
3. **Facteurs environnementaux** (50% des cas)
4. **Composante hormonale** (30% des cas)
5. **Stress comme facteur aggravant** (40% des cas)

Recommandations transversales:

1. **Éducation sur la protection solaire** systématique
2. **Adaptation des routines** selon les besoins spécifiques
3. **Approche holistique** incluant mode de vie et environnement
4. **Suivi à long terme** pour ajustements nécessaires

5. **Collaboration interdisciplinaire** quand nécessaire

Protocole de suivi:

- **Évaluation à 4 semaines** pour ajustements mineurs
 - **Bilan à 3 mois** pour évaluation de l'efficacité
 - **Suivi annuel** pour maintien et prévention
 - **Adaptation saisonnière** des routines
-

Cas #11: Peau adolescente avec acné polymorphe sévère

Profil du patient:

- Adolescent, 16 ans
- Acné inflammatoire grade 3-4 avec nodules et kystes
- Lésions sur visage, dos et décolleté
- Cicatrices en formation
- Impact psychologique important

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Très grasse
- Déshydratation: Oui, due aux traitements agressifs
- Brillance: Excessive malgré les traitements
- Rougeurs: Importantes autour des lésions
- Picotements: Fréquents avec les traitements actuels
- Imperfections: Très nombreuses et profondes
- Cicatrices: En cours de formation
- Estime de soi: Très impactée
- Traitements antérieurs: Multiples, sans succès durable
- Protection solaire: Irrégulière
- Routine: Découragement et abandon fréquents

Diagnostic:

Acné polymorphe sévère avec composante inflammatoire majeure et début de formation cicatricielle.

Recommandations personnalisées:

1. Consultation dermatologique urgente pour traitement systémique
 2. Nettoyage doux bi-quotidien sans sur-décapage
 3. Sérum apaisant et cicatrisant à base de niacinamide
 4. Hydratation légère adaptée aux peaux acnéiques
 5. Protection solaire non comédogène obligatoire
 6. Éviter manipulation des lésions
 7. Soutien psychologique si nécessaire
 8. Suivi rapproché pour ajustements thérapeutiques
-

Cas #12: Peau mature avec melasma post-ménopausique

Profil du patient:

- Femme, 52 ans, ménopausée
- Taches pigmentaires symétriques sur le visage
- Aggravation depuis l'arrêt des hormones
- Peau plus fine et moins élastique
- Antécédents de contraception hormonale prolongée

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Normale à sèche
- Déshydratation: Depuis la ménopause
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Parfois, sensibilité accrue
- Picotements: Avec les actifs dépigmentants
- Taches: Oui, symétriques et persistantes
- Ménopause: Depuis 2 ans
- Exposition solaire: Antécédents importants
- Protection solaire: Récente et irrégulière
- Routine: Basique, peur des actifs

Diagnostic:

Melasma post-ménopausique avec photovieillissement associé et barrière cutanée fragilisée.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux respectueux du film hydrolipidique
 2. Sérum dépigmentant progressif (hydroquinone encapsulée)
 3. Rétinol en concentration adaptée aux peaux matures
 4. Crème hydratante riche avec peptides anti-âge
 5. Protection solaire SPF 50+ teintée obligatoire
 6. Peeling chimique doux mensuel
 7. Éviter exposition solaire directe
 8. Patience (6-12 mois de traitement minimum)
-

Cas #13: Peau avec dermatite séborrhéique faciale

Profil du patient:

- Homme, 38 ans
- Plaques érythémateuses squameuses sur les ailes du nez
- Desquamation grasse au niveau des sourcils
- Démangeaisons et inconfort
- Aggravation en période de stress

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Mixte à grasse
- Déshydratation: Parfois
- Brillance: Modérée
- Rougeurs: Oui, avec desquamation
- Picotements: Avec démangeaisons
- Imperfections: Parfois
- Stress: Professionnel, facteur aggravant
- Squames: Oui, grasses et jaunâtres
- Protection solaire: Occasionnelle
- Routine: Abandonnée par découragement

Diagnostic:

Dermatite séborrhéique faciale avec composante inflammatoire et mycosique probable.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux avec gel sans sulfates
 2. Sérum anti-inflammatoire à base d'acide azélaïque
 3. Crème hydratante légère avec actifs antifongiques
 4. Éviter les corps gras occlusifs
 5. Protection solaire fluide non comédogène
 6. Gestion du stress (relaxation, sport)
 7. Consultation dermatologique si persistance
 8. Éviter grattage et manipulation des lésions
-

Cas #14: Peau avec hyperpigmentation post-acné et cicatrices

Profil du patient:

- Femme, 25 ans
- Acné passée mais séquelles importantes
- Cicatrices atrophiques et hypertrophiques
- Taches post-inflammatoires étendues
- Teint très irrégulier

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Mixte
- Déshydratation: Parfois
- Brillance: Légère sur la zone T
- Rougeurs: Autour des cicatrices
- Picotements: Avec certains actifs
- Cicatrices: Oui, de différents types
- Taches: Nombreuses et persistantes
- Teint: Très irrégulier
- Complexes: Importants
- Protection solaire: Récente

- Routine: Recherche de solutions efficaces

Diagnostic:

Séquelles post-acnéiques mixtes avec hyperpigmentation et cicatrices de différents types.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux bi-quotidien
 2. Sérum régénérant à base de rétinol et vitamine C
 3. Acides de fruits pour renouvellement cellulaire
 4. Crème hydratante avec facteurs de croissance
 5. Protection solaire SPF 50+ indispensable
 6. Peelings chimiques professionnels
 7. Microneedling ou laser pour cicatrices
 8. Patience et régularité sur 6-12 mois
-

Cas #15: Peau avec kératose pilaire et rugosité

Profil du patient:

- Femme, 29 ans
- Petites papules kératosiques sur les bras et cuisses
- Peau rugueuse et granuleuse
- Sécheresse cutanée généralisée
- Antécédents familiaux similaires

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Sèche
- Déshydratation: Constante
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Parfois autour des papules
- Picotements: Avec certains exfoliants
- Imperfections: Papules rugueuses
- Antécédents familiaux: Oui, similaires
- Exposition: Amélioration l'été

- Protection solaire: Occasionnelle
- Routine: Exfoliation excessive par découragement

Diagnostic:

Kératose pilaire avec sécheresse cutanée associée et tendance génétique.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux surgras
 2. Exfoliation chimique douce (acide lactique)
 3. Crème hydratante riche en urée et céramides
 4. Éviter exfoliation mécanique agressive
 5. Protection solaire pour éviter hyperpigmentation
 6. Exposition solaire modérée bénéfique
 7. Régularité absolue dans les soins
 8. Acceptation de l'amélioration progressive
-

Cas #16: Peau avec péri-orale dermatite

Profil du patient:

- Femme, 34 ans
- Papules érythémateuses autour de la bouche
- Évitement de la zone péri-labiale
- Sensation de brûlure et tiraillement
- Antécédents d'utilisation de corticoïdes topiques

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Sensible
- Déshydratation: Localisée autour de la bouche
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Oui, péri-orales spécifiquement
- Picotements: Importants avec brûlures
- Imperfections: Papules groupées
- Traitements antérieurs: Corticoïdes locaux

- Dentifrice: Fluoré
- Protection solaire: Évitée sur la zone
- Routine: Abandonnée par peur d'aggraver

Diagnostic:

Dermatite périorale avec sensibilisation de contact et antécédents de corticothérapie locale.

Recommandations personnalisées:

1. Arrêt immédiat de tous les topiques
 2. Nettoyage à l'eau claire uniquement
 3. Éviter dentifrice fluoré et cosmétiques parfumés
 4. Crème barrière neutre si nécessaire
 5. Protection solaire minérale douce
 6. Éviter occlusion et irritants
 7. Consultation dermatologique pour traitement spécifique
 8. Patience pour la récupération (plusieurs semaines)
-

Cas #17: Peau avec vitiligo localisé

Profil du patient:

- Homme, 27 ans
- Plaques dépigmentées symétriques sur les mains
- Extension progressive depuis 2 ans
- Antécédents de stress important
- Peau claire avec bronzage difficile

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Normale
- Déshydratation: Non
- Brillance: Modérée
- Rougeurs: Autour des plaques parfois
- Picotements: Non
- Dépigmentation: Oui, progressive

- Stress: Facteur déclenchant probable
- Exposition solaire: Risque de brûlure sur les plaques
- Protection solaire: Indispensable
- Routine: Recherche de solutions

Diagnostic:

Vitiligo localisé en phase active avec facteur de stress identifié.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage doux respectueux de la pigmentation
 2. Sérum antioxydant protecteur
 3. Crème hydratante neutre sans parfum
 4. Protection solaire SPF 50+ indispensable
 5. Éviter traumatismes cutanés
 6. Gestion du stress (relaxation, sport)
 7. Consultation dermatologique spécialisée
 8. Camouflage cosmétique si souhaité
-

Cas #18: Peau avec ichtyose vulgaire

Profil du patient:

- Femme, 31 ans
- Sécheresse extrême avec squames fines
- Peau "écailleuse" sur les jambes
- Aggravation en hiver
- Antécédents familiaux d'atopie

Réponses au questionnaire:

- Type de peau: Très sèche
- Déshydratation: Permanente et extrême
- Brillance: Jamais
- Rougeurs: Parfois par irritation
- Picotements: Avec certains produits

- Squames: Oui, fines et blanchâtres
- Saison: Aggravation hivernale
- Démangeaisons: Fréquentes
- Protection solaire: Difficile à appliquer
- Routine: Très hydratante mais insuffisante

Diagnostic:

Ichtyose vulgaire avec sécheresse cutanée majeure et variation saisonnière.

Recommandations personnalisées:

1. Nettoyage surgras minimal
 2. Exfoliation chimique douce (acide lactique)
 3. Crème très riche en urée et céramides
 4. Applications multiples quotidiennes
 5. Protection solaire adaptée aux peaux sèches
 6. Humidification des espaces de vie
 7. Éviter bains chauds et longs
 8. Suivi dermatologique régulier
-

Analyse des nouveaux cas ajoutés

Types de pathologies couverts:

1. **Acné sévère adolescente** - Cas complexe nécessitant traitement systémique
2. **Melasma post-ménopausique** - Troubles pigmentaires hormonaux
3. **Dermatite séborrhéique** - Pathologie inflammatoire chronique
4. **Séquelles post-acnéiques** - Cicatrices et hyperpigmentation
5. **Kératose pilaire** - Trouble de la kératinisation
6. **Dermatite périorale** - Pathologie iatrogène
7. **Vitiligo** - Pathologie auto-immune
8. **Ichtyose vulgaire** - Génodermatose

Particularités diagnostiques:

- **Facteurs déclenchants** identifiés (stress, hormones, médicaments)

- **Composantes génétiques** dans certains cas
- **Impacts psychologiques** variables
- **Nécessité de traitements spécialisés** pour plusieurs cas

Approches thérapeutiques spécifiques:

- **Traitements systémiques** parfois nécessaires
- **Thérapies physiques** complémentaires
- **Prise en charge holistique** incluant facteurs psychologiques
- **Suivi spécialisé** en dermatologie